

Dinámica uterina y presentación fetal

1. Introducción y relevancia clínica

El éxito de un parto eutócico depende del equilibrio entre los **tres “P” del trabajo de parto**:

Poderes (Power): contracciones uterinas y pujo materno.

Pasaje (Passage): pelvis ósea y partes blandas.

Pasajero (Passenger): feto (tamaño, presentación y posición).

La **dinámica uterina** corresponde a la **actividad contráctil del útero**, la cual genera borramiento y dilatación cervical, y permite el descenso fetal.

La **presentación fetal**, en tanto, se refiere a la **porción del feto que contacta con el estrecho superior de la pelvis**, siendo determinante para la vía y el tipo de parto.

□ En EUNACOM se evalúa frecuentemente la **interpretación de la dinámica uterina**, el **diagnóstico de hiperestimulación por oxitocina** o la **identificación de la presentación y posición fetal según tacto vaginal y planos de Hodge**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el trabajo de parto, el útero desarrolla una **actividad coordinada y rítmica**, resultado de:

- La acción de **oxitocina y prostaglandinas** sobre las fibras musculares del miometrio.
- El aumento de **uniones tipo “gap junctions”** (conexiones intercelulares) hacia el término del embarazo, que permiten una contracción sincrónica.
- La formación del **segmento uterino inferior**, que facilita la dilatación cervical.

Fisiología de la contracción

Cada contracción uterina tiene tres fases:

1. **Incremento (ascenso)** → aumento progresivo de la presión intrauterina.
2. **Acme (máximo)** → punto de máxima intensidad.

3. **Decremento (descenso)** → relajación progresiva.

Entre contracciones ocurre la **relajación uterina**, fundamental para la perfusión uteroplacentaria.

3. Dinámica uterina: parámetros principales

La **dinámica uterina normal** durante el trabajo de parto se caracteriza por contracciones:

- **Rítmicas.**
- **Coordinadas (sincronía entre fondo y cuerpo uterino).**
- **Efectivas (producen dilatación cervical).**

Parámetros básicos de la contracción

Parámetro	Definición	Valor normal en fase activa
Frecuencia	Número de contracciones por 10 min	3–5
Duración	Tiempo de cada contracción	40–60 s
Intensidad	Presión intrauterina durante acmé (mmHg)	40–60 mmHg
Tono basal	Presión uterina entre contracciones	<20 mmHg
Reposo uterino	Intervalo entre contracciones	>60 s

□ En la práctica clínica, la evaluación suele ser **clínica (palpación)**, pero puede objetivarse mediante **toco-dinamometría** o **catéter de presión intrauterina**.

Valoración clínica

- **Leve:** útero apenas tenso, fácil de deprimir con dedos.
 - **Moderada:** difícil de deprimir.
 - **Fuerte:** imposible de deprimir durante contracción.
-

4. Alteraciones de la dinámica uterina

A. Hipodinamia (inercia uterina)

Contracciones **débiles o infrecuentes**, incapaces de producir dilatación efectiva.

Causas:

- Fatiga uterina.
- Sedación excesiva.
- Sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidroamnios).
- Infección intraamniótica.

Manejo:

- Hidratación, control de analgesia.
 - Estimulación con **oxitocina** si no hay desproporción cefalopélvica.
-

B. Hiperdinamia (taquisistolia)

Más de **5 contracciones en 10 minutos**, o contracciones prolongadas (>90 s).

Causas:

- Exceso de oxitocina.
- Hipersensibilidad miometrial.

- Corioamnionitis o desprendimiento de placenta.

Consecuencias:

- Hipoxia fetal (por menor perfusión).
- Riesgo de rotura uterina.

Manejo:

- **Suspender oxitocina**, posicionar lateral izquierdo, oxígeno, hidratación.
- Considerar **tocolíticos (salbutamol, atosiban)** si persiste.

C. Hiperestimulación uterina

Hiperdinamia + alteraciones del registro fetal (bradicardia o desaceleraciones tardías).

Conducta inmediata:

- Suspender oxitocina.
- Administrar oxígeno y líquidos.
- Si no mejora: tocolítico.

5. Presentación y posición fetal

A. Definiciones básicas

Concepto	Definición
Situación fetal	Relación del eje fetal con el eje materno. Puede ser longitudinal, transversa u oblicua.

Presentación	Parte del feto que se presenta primero en el canal del parto.
Actitud	Relación de las partes fetales entre sí (flexión o extensión).
Posición	Orientación del punto de referencia de la presentación respecto al lado derecho o izquierdo de la madre.

B. Tipos de presentación

Presentación	Porción que contacta con el canal	Frecuencia
Cefálica	Cabeza (occipucio)	96–97%
Podálica	Nalgas o pies	3–4%
De hombro o transversa	Hombro o dorso	<1%

C. Subtipos de presentación cefálica

Tipo	Grado de flexión	Punto de referencia	Observaciones
Occipitocefálica	Cabeza flexionada	Occipucio	La más favorable

Sincipital	Cabeza parcialmente extendida	Bregma	Parto dificultoso
Frontal	Cabeza extendida	Frente	Parto imposible vaginal
Facial	Cabeza completamente extendida	Mentón	Cesárea si mentoposterior

D. Presentación podálica (de nalgas)

Tipos:

1. **Completa:** nalgas + pies flexionados.
2. **Incompleta:** nalgas solas.
3. **De pies:** uno o ambos pies son la parte de presentación.

☐ En EUNACOM, toda presentación podálica suele requerir **cesárea electiva**, salvo condiciones muy específicas (feto pequeño, multípara, parto avanzado).

E. Posiciones fetales (en presentación cefálica)

Dependen del **occipucio** (referencia ósea fetal) respecto a la pelvis materna.

Posición	Descripción	Frecuencia
Occípito izquierda anterior (OIA)	Occipucio hacia sínfisis púbica izquierda	60–70% (más común)
Occípito derecha anterior (ODA)	Occipucio hacia sínfisis derecha	25%

Occípito posterior

Occipucio hacia sacro

<10%, parto prolongado

6. Planos de Hodge

Sirven para valorar el **descenso de la presentación fetal** a través del canal del parto (palpación vaginal).

Plano de Hodge	Referencia anatómica	Significado
I	Promontorio al borde superior del pubis	Encajamiento inicial
II	Cara inferior del pubis	Cabeza a nivel del estrecho superior
III	Espinas ciáticas	Presentación fija
IV	Borde inferior del sacro	Presentación en el periné (salida inminente)

☐ En EUNACOM, el “plano de Hodge III” se asocia a “presentación fija” (ya no se puede movilizar la cabeza fetal).

7. Valoración clínica de la presentación y posición

A. Maniobras de Leopold (palpación abdominal)

1. **Primera:** identifica el fondo uterino → polo fetal superior.
2. **Segunda:** determina el dorso fetal (lateralidad).
3. **Tercera:** evalúa la presentación sobre el estrecho superior.

4. **Cuarta:** estima grado de encajamiento (desde el pubis).

□ “Cabeza dura y redonda que se balotea” → presentación cefálica no encajada.

B. Tacto vaginal obstétrico

Permite:

- Evaluar dilatación y borramiento cervical.
- Identificar la parte de presentación (fontanelas, suturas, nalgas, pies).
- Determinar posición fetal según suturas (sagital, lambdoidea, etc.).

Ejemplo:

- **Fontanela posterior (triangular)** hacia el pubis → **OIA (posición normal)**.
 - **Fontanela anterior (romboidal)** hacia el sacro → **Occípito posterior**.
-

8. Relación entre dinámica uterina y progresión del parto

El progreso del parto depende de la **coordinación entre contracciones efectivas y adecuada presentación fetal**.

Alteración	Causa posible	Consecuencia
Hipodinamia + OIA normal	Fatiga uterina	Detención de dilatación
Hiperdinamia + desproporción pélvica	Exceso de oxitocina	Sufrimiento fetal
Occípito posterior persistente	Falta de rotación	Trabajo prolongado

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Dinámica uterina normal: **3–5 contracciones/10 min, duración 45–60 s.**
2. **Hiperestimulación:** >5 contracciones/10 min o duración >90 s.
3. **Hipodinamia:** <3 contracciones/10 min → manejo con oxitocina.
4. **Presentación cefálica occipitoizquierda anterior (OIA)** es la más frecuente y favorable.
5. **Plano de Hodge III:** presentación fija.
6. **Maniobras de Leopold:** determinan situación, presentación y encajamiento.
7. **Flexión cefálica adecuada** → menor diámetro fetal y parto más fácil.



Errores comunes

- Administrar oxitocina sin descartar desproporción cefalopélvica.
- No suspender oxitocina ante hiperestimulación y sufrimiento fetal.
- Confundir occípito posterior con OIA (tacto erróneo).
- No usar partograma en evaluación de dinámica y descenso.
- No reconocer que presentación transversa → **cesárea obligatoria.**

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dinámica uterina** es el conjunto de contracciones que permiten la dilatación cervical y el descenso fetal.
2. Contracciones normales: **3–5 cada 10 min, 40–60 s de duración.**
3. **Hipodinamia:** débil o escasa → puede tratarse con oxitocina.
4. **Hiperestimulación:** >5 contracciones/10 min → suspender oxitocina.
5. **Presentación cefálica OIA** es la más frecuente y favorable.
6. Los **planos de Hodge** determinan el grado de encajamiento fetal.
7. Las **maniobras de Leopold y el tacto vaginal** son esenciales para identificar la posición fetal.